

Fecha Última Actualización: 05-01-2026 21:54:37

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Flor Elizabeth Palma Torres
Edad : 57a 10m 5d
Dirección : Aulin 124 V Jardín Versalles

Rut : 11.476.758-1
Fecha Nacto: 29/02/1968
Comuna : Maipu

N° Archivo : 2531993
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 1234 5678

N° Epicrisis
467762

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utac/ Utinx

Fecha Ingreso : 11/12/2025 02:06

Días Estadía: 25

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 05/01/2026 21:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Cefalea intensa 10/10

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES:

Mórbidos: aneurismas cerebrales, migraña

Cirugía: apendicectomía, várices

Alergias (-)

HISTORIA DE INGRESO A UTIM

El 11/12 a las 00.30 hrs aproximadamente comenzó con cefalea insidiosa y progresiva hasta 10/10, por lo que tomó AAS 300 mg. Dado persistencia de cefalea, consultó en HLF, donde se estudio con TC y AngioTC de encéfalo, el cual evidenció HSA de patrón aneurismático Fisher 3-4 sin hidrocefalia, motivo por el cual fue trasladada a HSR para evaluación por neurocirugía. Al ingreso, con GCS 15/15, sin focalidad, se indica LEV, nimodipino, normotensión con PAS <140 mmHg y se solicita DSA. En TC de control, con dilatación ventricular, por lo que se instaló DVE de urgencia, procedimiento detallado sin complicaciones, luego de lo cual se trasladó a recuperación y posteriormente a pabellón de angiografía. En procedimiento se describe presencia de múltiples aneurismas:

- ACI D° supraclinoidea: aneurisma del cavum 2.9x2.6mm y cuello 2mm, y uno distal de 9.3x7.2mm con cuello 5mm
- ACI D° previo a bifurcación de 4.4x6.1 y 5.5mm
- ACI I°: aneurisma del cavum 4.7x4.8mm con cuello 4.4mm; uno distal de 14x6.2mm y cuello 6.5mm; y 2 más distales
- AcomP aneurisma de 4.7x4.5mm
- Aneurisma bifurcación ACM I° 2.9x4mm

Se realiza embolización con coils del aneurisma de ACI D° supraclinoidea con mamelón apical (presuntamente responsable).

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

1. HSA aneurismática Fisher 3-4 (2/21)

- Embolización 11/12

2.- Hidrocefalia ¿ DVE FI

HISTORIA DE INGRESO A UPC:

Paciente con antecedentes de múltiples aneurismas intracerebrales. Ingresa traslada desde UTI neuro por debut de hemorragia intraparenquimatosa frontal derecha como complicación de enfermedad aneurismática previa. Esposo refiere paciente vigil con evolución súbita de cefalea 10/10 holocraneana, acompañado de convulsiones y compromiso de conciencia con pérdida de vía aérea. Se procede a control de vía aérea con inducción en SR y posterior control de imagen . A la

Fecha Epicrisis : 05/01/2026 21:54

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 05-01-2026 21:54:37

Página 2 de 2

evaluación destaca extenso foco hemorrágico frontal derecho con HSA difusa y efecto de masa, quedando fuera de alcance neuroquirúrgico. Se presenta para manejo por equipo de UPC y activación de equipo de procuramiento. Se informa a familiares sobre pronóstico y condición actual.

Evolucion es concordante con muerte encefálica

Al examen clínico, destaca ausencia de reflejos. Corneales (-) Tusígeno (-) Ausencia de gatillo al ventilador y en modalidad espontanea por 60 segundos, impresionando con muerte encefálica pendiente de certificar. Unidad local se comunica con Neurólogo de turno y se acuerda evaluación y eventual test de apnea. El día 04/01 no se puede concluir por lo que se difiere para el día 05/01

Se realiza EEG 05.01.2026 sin actividad bioeléctrica

Se realiza test de apnea el 05.01.2026 a las 21:18, concluyente con muerte encefálica, declarandose fallecimiento a las 21:36hrs

Se explica a familiares

Diagnóstico de Egreso

Hemorragia subaracnoidea aneurismática - Hematoma frontal extenso con efecto de masa

Hemorragia subaracnoidea aneurismática - HSD derecho / Hemoventrículo

Hemorragia subaracnoidea aneurismática - Aneurismas múltiples / .Aneurisma roto ACI supraclinoidea derecha a Embolización (11/12)

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

En epicrisis

Plan Post Alta

En epicrisis

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Gonzalo Núñez Muñoz
Médico Tratante (Staff)